

1. Datos del paciente

ID Paciente	P009
NHC	NHC-2022-009814
Nombre completo	Daniel Ortega Campos
Sexo	Hombre
Fecha nacimiento	30/01/1990
Edad	36 años
DNI	29.654.782-S
Teléfono	611 098 456
Municipio	Onda
Médico responsable	Dra. Elena Martínez Roca
Especialidad	Psiquiatría — Unidad de Patología Dual

2. Antecedentes personales

- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentación combinada (diagnóstico tardío en 2022, CIE-10: F90.2)
- Trastorno por consumo de alcohol, gravedad moderada, en remisión temprana desde hace 5 meses (CIE-10: F10.20)
- Trastorno por consumo de cannabis en remisión sostenida desde 2021 (CIE-10: F12.20)
- Trastorno adaptativo con ánimo depresivo (2021, resuelto)
- No alergias medicamentosas conocidas

Antecedentes familiares: Padre: trastorno por consumo de alcohol grave, actualmente en tratamiento. Madre: posible TDAH no diagnosticado (inquietud crónica, dificultades organizativas, impulsividad). Hermana menor: TDAH diagnosticado en la infancia.

3. Historia clínica actual

Paciente de 36 años con diagnóstico de TDAH presentación combinada realizado en 2022 a los 34 años, tras años de dificultades académicas y laborales no explicadas. Desde la infancia presenta dificultad para mantener la atención sostenida, inquietud motora, impulsividad en la toma de decisiones e incapacidad para organizarse. Repitió 2.º de ESO y abandonó estudios universitarios en dos ocasiones. Ha tenido 8 empleos en los últimos 10 años, ninguno mantenido más de 18 meses, generalmente por conflictos interpersonales derivados de la impulsividad o por bajo rendimiento. El consumo de alcohol comenzó a los 17 años de forma social, escalando a consumo diario de riesgo (60-80 g/día) entre 2019 y 2024 como mecanismo de automedicación para la ansiedad y la inquietud. El consumo de cannabis fue regular entre 2012 y 2021. Ingresó voluntariamente en unidad de desintoxicación en noviembre 2025 durante 14 días. Desde el alta mantiene abstinencia alcohólica verificada con controles. El diagnóstico de TDAH se realizó mediante evaluación neuropsicológica completa que evidenció déficit en atención sostenida, memoria de trabajo y funciones ejecutivas, con un CI total de 108 (rango normal). Actualmente trabaja como técnico informático en una empresa de soporte, con adaptaciones en el puesto (teletrabajo parcial, listas de tareas estructuradas). Convive con su pareja.

4. Exploración

Aspecto general	Consciente, orientado. Aspecto adecuado. Actitud colaboradora aunque inquieta
-----------------	---

Psicomotricidad	Inquietud motora evidente: se mueve en la silla, golpetea con los dedos, cambia de postura frecuentemente
Estado de ánimo	Eutímico. Afecto reactivo, lábil ante frustración
Pensamiento	Curso acelerado con tangencialidad ocasional. Se pierde en detalles irrelevantes. Contenido sin alteraciones
Atención	Atención sostenida deficitaria. Se distrae con estímulos externos durante la entrevista
Impulsividad	Interrompe frecuentemente. Responde antes de que se termine la pregunta
Cognición	Funciones ejecutivas enlentecidas. Dificultad con planificación secuencial. Memoria de trabajo limitada
Consumo de sustancias	Abstinencia de alcohol verificada (último control negativo hace 2 semanas). Niega consumo de otras sustancias
Peso / Talla / IMC	78 kg · 175 cm · 25,5 kg/m ²
Tensión arterial	126/80 mmHg
Frecuencia cardíaca	88 lpm, rítmica

5. Tratamiento actual

Fármaco	Posología
Metilfenidato OROS 54 mg	1 comp. en desayuno (liberación prolongada)
Naltrexona 50 mg	1 comp. en desayuno (prevención de recaída alcohólica)
Omega-3 (EPA/DHA) 1.000 mg	1 cáps. en desayuno (coadyuvante)

6. Resultados de laboratorio

Parámetro	Resultado	Ref.	Estado	Previo
GGT	48 U/L	< 40	Alto	124 U/L
GOT (AST)	32 U/L	< 40	Normal	68 U/L
GPT (ALT)	38 U/L	< 41	Normal	72 U/L
VCM	96,2 fL	80–100	Normal	102,4 fL
CDT	1,4 %	< 1,7 %	Normal	3,8 %
Hemograma	Normal	—	Normal	Macroцитosis
Glucosa	92 mg/dL	70–110	Normal	98 mg/dL
Perfil tiroideo	Normal	—	Normal	Normal
ECG	Normal	—	Normal	—

7. Plan de actuación

1. Mantener metilfenidato OROS 54 mg. Valorar aumento a 72 mg si persisten síntomas atencionales en revisión
2. Mantener naltrexona 50 mg hasta completar 12 meses de abstinencia verificada
3. Controles toxicológicos mensuales (alcohol y otras sustancias)
4. Psicoterapia individual semanal: TCC adaptada a TDAH + prevención de recaídas en consumo de alcohol
5. Grupo terapéutico de patología dual quincenal
6. Control analítico en 2 meses: perfil hepático, hemograma, CDT

7. Coordinación con médico de empresa para seguimiento de adaptaciones laborales
8. Revisión en consulta en 6 semanas

AVISO: Todos los datos de este documento son completamente ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de apoyo en salud mental.